

RESUMEN TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Dr. Guillermo Guevara Aliaga

El tratamiento de la hipertensión arterial ha tenido bastantes variaciones en los últimos años, por lo que se resumirá en lo siguiente:

1. El **objetivo** de PA es menor a **140/90**, aunque algunos autores prefieren 130/80. En pacientes con diabetes, daño renal (y según algunos en quienes tienen alto riesgo cardiovascular) sí se prefiere el corte de 130/80, aun cuando no está del todo claro el beneficio de este corte más estricto. La mayoría de los pacientes actualmente se prefieren manejar con fármacos y no solo con medidas generales. Estas últimas siguen estando plenamente indicadas.

2. Se prefiere actualmente iniciar directamente con **dos fármacos** de distinta familia, siendo obligatorio en quienes tienen PA mayores o iguales a 150/100 y recomendado por algunos autores en PA mayores o iguales a 140/90. La monoterapia sigue siendo aceptable y se elige en pacientes con PA menor a 140/90. La mezcla más habitual es (A) enalapril o losartán más (B) amlodipino o HCTZ (hidroclorotiazida).

3. Todas las familias de antihipertensivos tienen **eficacias similares**, pero actualmente el betabloqueo y los diuréticos han perdido algo de fuerza como fármacos de primera línea (evidencia débil), siendo más escogidos los IECA, ARA2 y bloqueadores del calcio dihidropiridínicos.

3.1. IECA y ARA2:

- Son igualmente buenos y seguros. Suelen ser uno de los fármacos con los que se inicia el tratamiento.
- Se debe elegir entre IECA o ARA2: no se dan juntos.
- Enalapril y losartán, respectivamente, son los más estudiados y baratos. El losartán tiene la ventaja de tomarse una vez al día, mientras que el enalapril debe ser dos veces al día.
- El captopril tiene vida media muy corta, por lo que solo sirve para las crisis hipertensivas (las que actualmente se manejan principalmente ajustando el tratamiento de base).
- El lisinopril es una opción en los pacientes con daño hepático crónico.
- Si el IECA produce tos o alergia, se puede reemplazar por un ARA2.
- IECA y ARA2 son de elección en diabéticos, insuficientes cardíacos y pacientes con proteinuria, ya que evitan la remodelación cardíaca y reducen la proteinuria y progresión del daño cardíaco y renal.
- Están contraindicados en estenosis renal, hiperkalemia sobre 6 mEq/L y en IRC con clearance < 30 ml/min o creatinina > 3mg/dl.

3.2. Bloqueadores del calcio:

- Existen dos tipos: dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos.
- Para la HTA se prefieren los dihidropiridínicos, que tienen poco efecto cardíaco y gran efecto hipotensor.

- En específico se prefiere el amlodipino, ya que los otros están obsoletos por tener vida media muy corta (nifedipino y nitrendipino).
- De los no dihidropiridínicos, el diltiazem tiene efecto antihipertensivo, aunque se usa solo cuando hay otras patologías que lo requieren (ej. proteinuria). El verapamilo tiene poco efecto hipotensor y más efectos cardíacos (por eso se usa en taquiarritmias más que en la HTA).
- El amlodipino puede generar edema de extremidades inferiores y RGE. En ese caso, debe ser cambiado.

3.3. Diuréticos:

- Las más usadas son las tiazidas, que incluyen la hidroclorotiazida (HCTZ), indapamida y clortalidona.
- La clortalidona es más eficaz que la HCTZ, pero es más cara y tiene mayor riesgo de hipokalemia.
- Se complican con hipokalemia, hiponatremia, algo de hipercalcemia, pero también con dislipidemia y resistencia a la insulina (por lo que se usan con cuidado en diabéticos).
- Son de elección en pacientes con edema, hipercalciuria y osteoporosis, ya que aumentan la excreción de volumen y reducen la excreción de calcio, a nivel renal.
- La hipokalemia que generan las tiazidas se agrava con el consumo de sal.
- Los diuréticos de asa (furosemida, torasemida) no se usan como tratamiento de la hipertensión arterial.

3.4. Betabloqueantes:

- El más usado es el atenolol.
- Algunos estudios recientes han mostrado una ligera menor eficacia que otros antihipertensivos.
- Están contraindicados en asma y EPOC, además de en pacientes con bradiarritmias o riesgo de tenerlas (ej. Bloqueo AV). Están relativamente contraindicados en diabéticos con insulina o riesgo de hipoglicemia, ya que pueden ocultar los síntomas de hipoglicemia.
- Son útiles en ciertas patologías como la insuficiencia cardíaca (se prefiere carvedilol), fibrilación auricular y jaqueca, por lo que son de elección en pacientes con estas patologías.

3.5. Inhibidores de la aldosterona:

- Incluyen la espironolactona y la eplerenona.
- La eplerenona es un derivado de la espironolactona más caro, pero más específico sobre el receptor de aldosterona, por lo que tiene menos efectos antiandrogénicos y progestágenos (menos alteraciones menstruales o sexuales).
- Se complican con hiperkalemia.

- Se usan como última línea en la HTA refractaria (no responde a 3 fármacos, incluyendo una tiazida), mientras se realiza el estudio de HTA secundaria.
- También se usan cuando hay otra patología que los requiera (ej. insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular, ascitis).

4. El tratamiento se ajusta al inicio cada 2 a 4 semanas. Una vez logrado el objetivo, se ajusta cada 3 meses. Se recomienda controlar con creatinina y electrolitos 1 a 3 semanas después del inicio de IECA, ARA2 y diuréticos.

- Si no responde con un fármaco, se agrega un segundo. Si no responde con 2 fármacos, se agrega un tercero. Si no responde con 3 fármacos, se agrega espironolactona.
- Si alguno produce efectos adversos, se reemplaza por otro.
- Los casos refractarios, muy severos o que no parecen una HTA esencial, deben ser estudiados para causas de HTA secundaria y tratar según hallazgos.